جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سعاد عبدالقوى ميزار ميزار
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** مممممممممممم
رقم البطاقة : 25612162300881 **رقم التليفون :** 01156632266 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 16-12-1956 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سعاد عبدالقوى ميزار ميزار
National ID: 25612162300881

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Name: Mrs. Soad Abdulkawey Mizar
Date: 2025-12-28

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM & ALAND, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion: -

Left breast (BIRADS 2): Diffuse breast adenosis.
Clear right mastectomy bed and axilla.

Recommendation:-

For annual follow up.

Best Regards,
DR, Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

[[DOCTYPE:ID_FRONT]]
National ID – Front



٢٥٦١٢١٦٢٣٠٠٨٨١ ٢٠٢٢/٠٦

ربة منزل

أنثى مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٦/٠٧ ١



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL ABOUTE

Patient Name: Souad Abdel Kawy Mizar Mizar	Date : 23/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 69 Year(s)
Medical ID: 3867/2019	Pat. ID: 43519

POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

History: Right MRM for metastatic work up.

Compared to last study dated 03/5/2025, the current study shows;

I-CHEST :

- Right mastectomy with clear opertaive bed , no masses or collections.
- Still noted Few Bilateral millimeteric scattered pulmonary nodules , the largets seen right middle lobe measures about 2-4 mm compared9 mm priorly.
- Mosaic perfusion of both lung lobes.
- No hilar or mediastinal lymph nodes
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross abnormalities.

II-Abdomen & pelvis

- Enlarged liver with ***no appreciable changes regarding*** few bilobar non enhancing hypodense rather cystic focal lesions, Largest at segment II measuring 6 mm.
- **Resolution of** circumferential mural thickening with submucosal edema pattern of the hepatic flexure, ascending colon and caecum with suspected focal abnormal configuration of the caecum and appendix displaying internal fat content.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Right kidney shows cortical cyst measuring 12 mm.
- Marked atherosclerotic changes of abdominal aorta is noted with attenuated left renal artery showing opposed calcified atheromatous plaques for renal Doppler correlation.
- Normal appearance of the pancreas, I.V.C and both supra-renals.
- Underfilled urinary bladder hindering its proper assessment with no radiodense stones.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13007606
Patient No.	: 25612162300881	Request Date	: 22/12/2024
Path No.	: SR-1917/24	Verification Date	: 04/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 68 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast masses.

Nature of specimen:
Slides revision (Right modified radical mastectomy).

Gross examination:
Eleven referred slides were received including 3 immunostained slides for (ER, Pr & HER2), labelled by patient name.

Microscopic examination
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+3+2) Grade III.
- DCIS: Not detected.
- Angioinvasion: Present.
- Perineural invasion: Not detected.
- Skin involvement : Free nipple and areola.
- Lymph nodes: Positive metastatic deposits in three lymph nodes, L.N (3/18), with capsular extension.
- Resected margins: Please referre to the original report.
- IPT: The received immunostained slides are not reliable.

Diagnosis
Right breast cancer , Slides revision (Right modified radical mastectomy):
- Invasive duct carcinoma, Grade III.
- Free nipple and areola.
- Positive metastatic depossits in three lymph nodes, L Ns (3/18).
- Comment: Blocks are needed for performing immunophenotyping

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (1) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No.(1) - First Floor-Building No. 987- Nile Cornishe - Misr El Qadema - Cairo - Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / سعده عبد القوى مبروك مبروك	Request No.	: 13007606
Patient No.	: 256121623008B1	Request Date	: 22/12/2024
Path No.	: SR-1917/24	Verification Date	: 04/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 68 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty.
Dr. Manwa Mahmoud.

Verified by:
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Souad Abdel Kawy Mizar Mizar	Date : 11/01/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 68 Year(s)
Medical ID: 3867/2019	Pat. ID: 43519

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

History: Right MRM for metastatic work up.

Compared to last study dated 25/12/2023

I Chest: -

- Evidence of right MRM with clear operative bed.
- Bilateral scattered subpleural atelectatic bands.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with **rather stationary** few bilobar hypodense focal lesions largest at segment II measuring 7 mm.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Right kidney shows cortical cyst measuring 12 mm.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Souad Abdel Kawy Mizar Mizar	Date : 11/01/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 68 Year(s)
Medical ID: 3867/2019	Pat. ID: 43519

- Marked atherosclerotic changes of abdominal aorta is noted with attenuated left renal artery showing opposed calcified atheromateous plaques for renal Doppler correlation.
- Normal appearance of the pancreas, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- No suspicious osseous lesions.

Opinion:

- **Stationary course since last study.**

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]